

らくらく予防プラン

要支援は「できるけれど、ちょっと不足」。

4領域の整理から、総合的課題・目標・支援内容まで、予防プランの作成をサポートします。

オフライン完結 / AI不使用 / インストール不要



使い方マニュアル

要支援の「できる、でも少し不自由」を起点に考える作成支援ツール

最初に

このツールはケアプランを自動で決めるものではありません。本人の言葉とケアマネジャーの判断をもとに、考える順番と文章整理を補助するツールです。

このツールの3つの役割

区分	何を入れる？
本人の言葉	1日・1年の生活、各領域の「どうしたい」、提案に対する意向
人が選ぶ	生活機能3段階、課題の着地点、まとめ方、目標を採用・修正・見送る判断
ツールが整理	サービス区分の判定、課題文の叩き台、総合的課題、支援欄、転記用平文

基本の流れ

最短ルート

①区分・サービス → ②目標とする生活 → ③4領域 → ④総合的課題 → ⑤提案・意向 → ⑥目標 → ⑦支援内容 → ⑧転記

オフライン完結・AI不使用・インストール不要。

入力内容はこの端末に保存されます。自動保存ではありません。

共用端末では、使い終わったら「新しく始める」で入力と途中保存を消してください。

0 最初に、今回の区分と「目標とする生活」を入れる

ここで拾った情報は、後ろの領域・方針・転記用の平文で使います。

0 今回の区分を確認

対象者と利用するサービスから、介護予防支援／介護予防ケアマネジメントを判定します。

認定区分

要支援1

要支援2

事業対象者

申請中

今回利用するサービス

サービス名を選ぶと、予防給付か総合事業かはツールが判定します。

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修

介護予防短期入所生活介護

介護予防居宅療養管理指導

訪問型サービス

通所型サービス

その他

訪問型サービス・通所型サービスは、自治体により訪問型サービスA、生活支援訪問サービス等の名称場合があります。

認定区分を選ぶと判定します。

世帯・支援環境

全領域に効く情報なので、ここで一度だけ拾います。当てはまるものを選びます。

独居

日中独居

高齢者のみ世帯

同居家族あり

支援できる家族等が近くにいる

家族等の支援が得にくい

その他

認定区分・今回利用するサービス・世帯／支援環境を選びます

1. 認定区分を選びます。要支援1・要支援2・事業対象者・申請中から選択します。
2. 今回利用するサービスを選びます。予防給付か総合事業かはツールが整理します。
3. 世帯・支援環境は、全領域に関係するものだけをここで一度拾います。
4. 介護予防ケアマネジメントの類型（A/B/C等）は自治体ごとに運用が異なるため、自動判定しません。

生 目標とする生活

本人の言葉で書きます。ここはツールが組み立てません。書いた内容がそのまま転記用に出ます。

1日の目標とする生活

1日の中でできるようになりたいこと、続けたいこと。

例：朝は自分で朝食を作り、午前中に近所を一回りする。

1年の目標とする生活

1年後にどうなっていたいか。

例：来年もこの家で、自分の食事を作りながら一人暮らしを続けている。

1日をコピー

1年をコピー

健康状態について

主治医意見書、生活機能評価等を踏まえた留意点。病名や治療の状況など、事実をそのまま書きます。ツールは組み立てません。

例：糖尿病で内科に月1回通院。内服にて経過観察中。血糖値の管理について主治医より食事の注意あり。

この欄をコピー

1日・1年の「目標とする生活」と健康状態は、本人の言葉・事実をそのまま入力

ここはツールが作らない

「1日の目標とする生活」「1年の目標とする生活」「健康状態について」は、入力した内容がそのまま転記に使われます。本人の言葉や主治医意見書等の事実をそのまま入れてください。

1 4領域は、まず「生活機能の3段階」から

認定区分ではなく、その領域での生活機能そのものにいちばん近いものを選びます。

1 この領域の生活機能

認定区分に関わらず、生活機能そのものでいちばん近いものを1つ。

自分でできており、不自由はほぼない

自分でできているが、不自由・負担が少しある

自分でできているが、一部に補助が必要な場面がある

できている生活の中の引っかかりを拾います。ここが要支援の中心です。下の「取り戻したい・改善したいこと」に一言入れると、課題の着地点が具体的になります。

3段階の見方

① 自分でできており、不自由はほぼない

課題を無理に作りません。本人の「続けたいこと」を確認し、課題なしとして進めます。

② 自分でできているが、不自由・負担が少しある

要支援の中心。できている生活の中の「引っかかり」を拾います。背景・原因は必須ではありません。

③ 自分でできているが、一部に補助が必要な場面がある

本人の望み、背景・原因、残っている力を確認して課題を置きます。状態変化の確認メッセージが出る場合があります。

領域は4つ

運動・移動

日常生活（家庭生活）

社会参加・対人関係

健康管理

大事な考え方

「できないこと」を探すのではなく、まず“できている”。そのうえで、どこに少し不自由・負担・補助があるかを見ます。

2 課題文を作るまで

入力するのは必要なところだけ。最後の「課題の着地点」は人が選びます。

2 現在の状態

当てはまるものだけ。無理に選ばなくて構いません。

歩行不安定

屋外移動が難しい

転倒あり

外出減少

その他

この領域の状況に足したい一言（任意）

いつから、どのくらいの頻度、どこまでならできると。この領域のことだけ書きます。空欄で構いません。

例：半年ほど前から外出は週1回程度。徒歩5分のスーパーまでは行ける。

現在の状態／状況の一言

3 本人・家族の意欲・意向

本人がどうしたいか、感じたいことを、本人の言葉で。

回りごとではなく、どうしたいかを書きます。本人が言った言葉だけを入れ、下の「3つの欄を作る」で出した文は貼り戻さないでください。

例：近所のスーパーへ自分で買い物に行きたい。

▶ 家族の気づき・意向がある場合だけ

本人・家族の意欲・意向

4 背景・原因

不自由・負担が少しある場合、背景・原因は書かなくても構いません。

▶ 背景・原因を書く場合だけ

背景・原因（必要な場合）

5 本人の力

今できていること。ここが課題の着地点の材料になります。

屋内移動可能

短距離歩行可能

補助員使用で可能

外出意欲あり

その他

本人の力

6 領域における課題

「何をするか」ではなく、今の課題を置きます。

ここでは目標を作りません。サービス名や「機会を増やす」などの具体策には踏み込みません。

課題の着地点

取り戻したい・改善したいことがあれば、まずここに一言

入れると、下の候補に改善系が加わります。例：握力／左手の筋力／食事の管理
空欄のままだと、維持と意欲の候補しか出ません。

例：食事の管理

上の選択から作った候補です。タップして選びます。

現在の生活を継続できる状態を保つこと

▶ 候補が合わない場合だけ開く

課題文を作る

生成した課題文

課題の有無：有

ここに課題文が出ます。直接加筆できます。

OK：領域の状態を3段階で確認した

確認：本人が望んでいることが空です。課題文を作り直してください

確認：課題の着地点を人が選んだ

OK：抽象語の自動生成なし

OK：具体策・サービス名なし

取り戻したい・改善したいこと → 着地点を選択 → 「課題文を作る」

「本人がどうしたいか・続けたいこと」は本人の言葉で入力します。生成文を貼り戻さないでください。

「取り戻したい・改善したいこと」に一言入れると、改善系の着地点候補が増えます。

候補が合わないときは直接入力できます。ツールに無理やり合わせる必要はありません。

生成した課題文は叩き台です。必要ならその場で加筆・修正します。

最後に「3つの欄を作る」を押すと、現在の状況／意欲・意向／領域における課題を分けてコピーできます。

3 総合的課題から目標へ

ここからは「専門職の整理 → 提案 → 本人の返事 → 目標」の順です。

総 総合的課題

4領域の課題をまとめます。更支援は1本、多くても2本が目安です。

ここでも目標は作りません。何が課題かまでを書きます。

4領域で課題文を作ると、ここに並びます。

総合的課題

提 課題に対する目標と具体策の提案

総合的課題ごとに、こういう方向でどうですかという提案を書きます。まだ目標そのものではありません。

ここは提案です。本人・家族の意向を聞く前の、専門職からの案として書きます。

先に総合的課題を作ってください。

提案の聞き台を作る

生成した提案

直接加筆・修正できます。

総合的課題を作ってから押してください。

この欄をコピー

確認：まだ作っていません

OK：抽象語の自動生成なし

OK：ここは提案。本人・家族の意向を聞いてから目標を決めます

課題に対する目標と具体策の提案

意 具体策についての意向

上の提案に対する本人と家族の返事を、言葉のまま書きます。ツールは組み立てません。

同意、迷い、断り、どれもそのまま書きます。提案と違う返事でも登えませんか。

本人の意向

例：デイでの体験は続けたい。食事は好きなものを我慢し
たくない。

この欄をコピー

家族の意向（ある場合だけ）

例：無理のない範囲で続けてほしい。食事は自分たちも気
をつけたい。

この欄をコピー

確認：本人の意向が未入力です

具体策についての意向

標 目標

提案と意向がそろうから決めます。候補から選び、言い回しは直観なおしてください。

目標は本人が主語です。サービス名や支援者がすることは書きません。

先に総合的課題を作ってください。

目標の聞き台を作る

生成した目標

直接加筆・修正できます。期間は様式に合わせて書き足してください。

総合的課題を作ってから押してください。

この欄をコピー

確認：まだ作っていません

確認：本人の意向を聞いてから決めた

OK：抽象語の自動生成なし

OK：サービス名なし

OK：期間は様式に合わせて書き足してください

目標

1. 総合的課題：4 領域の課題を 1〜2 本に整理します。着地点が違う場合は分ける方が本人の生活が見えやすくなります。
2. 目標と具体策の提案：まだ決定ではありません。「こういう方向でどうですか」という専門職からの案です。
3. 具体策についての意向：本人・家族の返事を言葉のまま入力します。同意・迷い・断りもそのままです。
4. 目標：提案と意向を踏まえ、「そのまま進める／本人の希望を優先／範囲をしばる／今回は見送る」から扱いを選びま
す。

「今回は見送る」を選んだら

その課題は、支援のポイント・セルフケア・総合的な方針から外れます。全部見送った場合、セルフケアも空のままに
なります。

目標の文章が本人らしくないとき

「本人の希望を優先」は自動文なので、組み合わせによっては不自然になることがあります。目標の一言入力欄で、本人の言葉に寄せて書き直す前提で構いません。

4 支援内容を整理して、最後に転記する

採用した目標に必要な情報だけを後半へ流します。

点

目標についての支援のポイント

目標に向けて、支援する側が気をつけることを置きます。本人がすることはありません。

先に目標を作ってください。

支援のポイントの印き台を作る

生成した支援のポイント

直接加筆・修正できます。

目標を作ってから押してください。

この欄をコピー

確認：まだ作っていません

OK：支援する側が気をつけること（本人がすることは目標の欄へ）

OK：抽象語の自動生成なし

目標についての支援のポイント

緑

本人等のセルフケア、家族の支援、地域の活動

サービス以外で支える部分です。要支援では、ここが本体になることも多い欄です。

印き台を作る

本人等のセルフケア

本人が自分で取り組むこと。今できている力を使う形で書きます。

例：毎日の散歩を続ける。体調の変化があれば受診時に伝える。

この欄をコピー

家族の支援

家族等が実際に行う支援を書きます。具体的な支援がない場合は「現時点で具体的な支援なし」とします。

例：週1回の電話で体調を確認する。

この欄をコピー

地域の活動

近隣、友人、サロン、老人会、民生委員など。

例：近所の友人と声をかけ合う。公民館の集まりに参加する。

この欄をコピー

確認：セルフケアが空です。要支援ではここが本体になります

セルフケア・家族・地域

支援のポイント：支援する側が気をつけることを選びます。独居かつ家族等の支援を得にくい場合は「必要時に支援につながる体制を確認する」が加わります。

本人等のセルフケア：採用した目標に関係する「本人の力」と目標だけを使います。

家族の支援：家族が実際に行うことだけを書きます。具体的な支援がない場合は「現時点で具体的な支援なし」とします。

地域の活動：近所、友人、サロン等、実際にある関わりを記載します。存在しない支援は作りません。

サ

介護保険サービスまたは地域支援事業

上で選んだサービスに、事業所と頻度・期間を足します。

上の「今回利用するサービス」を選んでください。

サービス欄を作る

生成したサービス欄

直接加筆・修正できます。

上でサービスを選んでから押してください。

この欄をコピー

確認：まだ作っていません

サービス種別・事業所・頻度・期間

引

入力内容の持ち出し・貼り戻し

新しい版のファイルに入力内容をそのまま移せます。ファイルをまたいで使えます。

今の入力を書き出す

貼り付けた内容を読み込む

コピー

「今の入力を書き出す」を押すと、ここにデータが出ます。これをコピーして保管し、新しい版のファイルのこの欄に貼って「読み込む」を押すと復元できます。

このデータはこの端末のなかだけで完結します。どこにも送信されません。

入力内容の持ち出し・貼り戻し

サービス欄：サービスごとに事業所名・頻度・期間を入力します。サービスを外しても、残ったサービスの入力内容は保持されます。

途中保存：自動保存ではありません。「途中保存」を押して保存します。

入力内容の持ち出し：書き出したデータをコピーして保管し、新しい版の同じ欄へ貼り付けて読み込めます。何度書き出してもデータは自己増殖しません。

記 全体の転記用の平文

入力した領域をまとめて出します。記録として残す用です。

転記用を作る

コピー

「転記用を作る」を押すところに出ます。

見出しは一般的な日本語と改行のみで構成し、Markdown、太字記号、丸数字、機種依存文字は使いません。

最後に「転記用を作る」→平文をコピーして記録・計画書へ

転記前の最終チェック

本人の言葉が残っている／課題・目標にサービス名が入り込んでいない／家族支援欄に環境情報を書いていない／頻度・期間の未入力がない／自治体独自の類型や運用は別途確認した、を見直してください。

5 困ったとき・公開版の注意

「自動生成されたから正しい」ではなく、最後は必ず人が読んで整えます。

よくある迷い

「不自由はほぼない」なのに課題を書きたくない	課題を無理に作らず、本人の続けたいことを確認して「課題なし」で進めます。
本人の望みと課題の着地点がうまくつながらない	候補を無理に使わず、着地点の直接入力・目標の一言入力を使います。

家族等の支援が得にくい	それは世帯・支援環境の情報です。家族支援欄には、実際の支援がなければ「現時点で具体的な支援なし」とします。
総合的課題を1本にまとめるか迷う	着地点が違えば分ける方を優先。1本にまとめること自体を目的にしません。
旧版の入力を新しい版へ移したい	「今を入力を書き出す」→コピー→新しい版へ貼付→「読み込む」で移せます。

このツールの守備範囲

介護予防サービス・支援計画書の作成を補助するためのツールです。制度・自治体運用・事業所ルール等は地域や時期によって異なるため、必要な確認は各自で行ってください。

一番大事なこと

本人の力を前提に、本人の言葉を残し、ツールが勝手に人生を決めない。迷ったら、自動生成文より本人とケアマネジャーの判断を優先してください。

以上で基本操作は完了です。使いながら迷ったところが、そのまま次の改善ポイントになります。